SDD 206 Sujet n°1

Spécialité : Diabétologie

Date : 05/01/2025
Autrices : Clara DANIELLOT (DES endocrinologie-diabétologie-nutrition, EN 2024), Maïla MOULIN (DES médecine générale, EN 2024)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (DES médecine interne, EN 2023), SAMANNI Léa (DES Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Education/prévention
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	240 - Hypoglycémie 247 - Diabète de type 1 et 2
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 206 - Hypoglycémie
Matériel nécessaire à la station	Une table, deux chaises
Contexte de la station	Consultation de suivi en ville

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

Vous êtes endocrinologue, vous recevez M. T. que vous suivez depuis 7 ans pour son diabète de type 2 traité par METFORMINE et SITAGLIPTINE (inhibiteur de DPP4). Il n'a pas d'autre antécédent et ne prend aucun autre traitement. Malgré l'introduction des deux traitements et la bonne observance, l'HbA1c est à 9%.

Vous avez décidé de lui prescrire de l'insuline lente et rapide devant le déséquilibre de ce diabète.

Au cours de cette station, vous devez :

- Expliquer à M. T. pourquoi il est sujet aux épisodes d'hypoglycémie.
- Lui expliquer comment prévenir, identifier et traiter ces hypoglycémies.

Vous ne devez pas :

- Indiquer les posologies d'insuline

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Indique que la **METFORMINE** et la **SITAGLIPTINE** n'exposent **pas au risque d'hypoglycémie**.	1 pt	☐
2.	Identifie le risque d'**hypoglycémie** associé à la prise **d'insuline**.	1 pt	☐
3.	Évoque le seuil de 0,7 g/L pour parler d'hypoglycémie chez un patient diabétique.		
4.	Évoque les **symptômes adrénergiques**, au moins 3 parmi : - pâleur - sueur - tachycardie/palpitations - tremblements - sensation de chaleur - sensation de faim - anxiété	1 pt	☐
5.	Évoque les **symptômes neuro-glucopéniques**, au moins 2 parmi : - confusion - convulsions - troubles focaux (ou un parmi moteur, sensitif, diplopie, paralysie faciale, trouble de l'élocution) - troubles visuels - troubles de la concentration	1 pt	☐
6.	Indique la nécessité de prendre une glycémie capillaire si signe adrénergique/neuro-glucopénique		
7.	Dit qu'en cas d'hypoglycémie, si le patient est **conscient**, il doit manger l'équivalent de 15 grammes de sucre, soit **(au moins 1 des 4 éléments pour avoir le point)** - 3 morceaux de sucre, - 1 verre de soda ou de jus de fruit, - 1 barre sucrée, - 1 cuillère à soupe de miel ou de confiture	1 pt	☐
8.	Dit qu'en cas d'hypoglycémie, si le patient est **inconscient**, le traitement est une **injection IM/SC ou intranasale de Glucagon par l'entourage**	1 pt	☐
9.	Explique au patient qu'il doit diminuer la **dose d'insuline rapide ou prendre une collation sucrée avant un effort important.**	1 pt	☐
10.	Explique qu'il ne faut **pas faire la dose d'insuline rapide si le patient saute des repas.**	1 pt	☐

11.	Explique que le traitement est un **ajout et non un remplacement** des antidiabétiques oraux.	1 pt	☐

Communications et attitudes

12.

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

13.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

14.

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

15.	**11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)**				
	Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
	Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie
TOTAL					**15 points**

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes endocrinologue, vous recevez M. T. que vous suivez depuis 7 ans pour son diabète de type 2 traité par METFORMINE et SITAGLIPTINE (inhibiteur de DPP4). Il n'a pas d'autres antécédents et ne prend aucun autre traitement. Malgré l'introduction des deux traitements et la bonne observance, l'HbA1c est à 9%.

Vous avez décidé de lui prescrire de l'insuline devant le déséquilibre de ce diabète.

Au cours de cette station, vous devez :

- Expliquer à M. T. pourquoi il est sujet aux épisodes d'hypoglycémie.
- Lui expliquer comment identifier, traiter et prévenir ces hypoglycémies.

Plan de la station ECOS :

Patient et médecin face à face séparé par une table.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

Bonjour docteur, j'ai vu sur ma prise de sang que mon diabète n'était pas très bien équilibré. Qu'est ce que vous en pensez et qu'est ce que vous me proposez ?

Identité du patient :

Sexe, nom/prénom, âge, taille, poids

Ronald T., 48 ans
180 cm, 100 kg

Mode de vie :

Guide de haute montagne
Marié, 3 enfants

Comportement global :

Vous êtes un peu inquiet vis à vis du traitement car vous êtes guide de haute montagne et partez souvent toute la journée faire des grandes randonnées.
Vous êtes néanmoins motivé pour bien équilibrer votre diabète et êtes très observant sur vos médicaments.
Vous comprenez bien ce que le médecin vous dit.

Antécédents personnels :

- Diabète de type 2 depuis 7 ans
- 0 autre antécédent personnel

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

Bien distinguer le traitement de fond (= habituels) des traitements pris récemment dans le cadre de la situation clinique (ex prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs)

- METFORMINE depuis 7 ans
- SITAGLIPTINE depuis 2 ans

Symptômes positifs :

0

Questions de relance :

- A 6 minutes, si le glucagon n'a pas été évoqué : Comment je fais si j'ai un malaise vu que je passe toutes mes journes à guider des gens dans la montagne ?

- Si l'étudiant ne l’évoque pas spontanément, demander si la Metformine ou la Sitagliptine expose aux hypoglycémies